



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KEGIATAN

KOMITE MUTU RS. PRIMA HUSADA SUKOREJO

TRIWULAN III TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54,

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU TRIWULAN III
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Sukorejo, 30 September 2025

Telah Disetujui Oleh :

Direktur PT. Disa Prima Medika

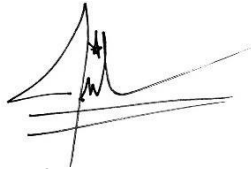


(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP, CHAE.)

Disetujui,
Oleh

PLT. Direktur RS. Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan III Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada bulan berikutnya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan III Tahun 2025. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHANii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.2 Tujuan..... 1

1.2.1 Tujuan Umum..... 1

1.2.2 Tujuan Khusus 1

BAB II 2

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU..... 2

BULAN TRIWULAN III TAHUN 2025 2

2.1 Kegiatan Pokok 2

2.2 Kegiatan yang Dilakukan 3

2.3 Jadwal Kegiatan..... 3

2.4 Pencatatan dan Pelaporan 3

BAB III 4

HASIL KEGIATAN 4

3.1 Pemantauan Indikator Mutu 4

3.1.1 Indikator Mutu Nasional 4

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional..... 5

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 20

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
23

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit..... 37

1. INSTALASI GAWAT DARURAT 37

2. INSTALASI RAWAT JALAN 38

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A..... 40

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B..... 42

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A..... 44

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B..... 45

7. INSTALASI KAMAR OPERASI 47

8. MATERNITAS 49

9. PONEK..... 51

10. NEONATOLOGI..... 52

11. ICU..... 53

12. RADIOLOGI..... 54

13. LABORATORIUM 55

14. REHAB MEDIS 56

15.	FARMASI	57
16.	GIZI.....	58
17.	REKAM MEDIS	58
18.	LIMBAH – K3RS	59
19.	SDM.....	59
20.	KESEKRETARIATAN	60
21.	DRIVER.....	60
22.	PEMULASARAAN JENAZAH	61
23.	ATEM – IPSRS	61
24.	LAUNDRY.....	61
25.	CSSD	62
26.	CLEANING SERVICE	63
27.	KEAMANAN	63
28.	GUDANG UMUM.....	64
29.	PPI	64
30.	PKRS.....	65
31.	ASURANSI CENTER	66
32.	HUMAS & MARKETING	66
33.	CSO	66
34.	MOD-MPP-PIPP	67
35.	TB di IRJA.....	67
36.	KEUANGAN	67
37.	TIM HIV	68
38.	KB	68
39.	STUNTING	68
40.	IT - SIM RS.....	69
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM MUTU LAINNYA .		Error! Bookmark not defined.
4.1	Prorgram Sasaran Keselamatan Pasien	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi RS Prima Husada Sukorejo adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi RS Prima Husada Sukorejo, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat, (2) mengutamakan kepuasan pasien, (3) meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien RS Prima Husada Sukorejo melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan di semua unit kerja untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dari KARS STARKES berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikannya indikator rumah sakit sebagai berikut : Indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Rumah sakit (IMP-RS) yang meliputi : indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem dan indikator terkait manajemen resiko, kemudian yang ketiga yakni insikator mutu prioritas unit.

Identifikasi prosedur, proses dan hasil dari kegiatan yang dinilai sebelumnya pada tahun 2024, disertai tujuan untuk menekan permasalahan yang ada di rumah sakit mendasari dipilihnya indikator baru di indikator prioritas. Kriteria pemilihan tetap didasarkan pada kasus yang memiliki volume tinggi, resiko tinggi atau biaya tinggi, disesuaikan dengan visi dan misi rumah sakit. Laporan Komite Mutu pada Triwulan III Tahun 2025 terkait indikator mutu diambil oleh unit kerja.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di setiap unit di RS Prima Husada Sukorejo

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi peningkatan mutu RS Prima Husada Sukorejo melalui pemantauan indikator mutu internal atau eksternal berdasarkan standar Komite Mutu Tahun 2024
2. Mengevaluasi program keselamatan pasien dengan pemantauan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKP-RS)
3. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu lain, yang dilakukan oleh unit terkait dengan peningkatan mutu yakni:
 - a. Program manajemen resiko
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja
4. Menganalisis capaian indikator mutu unit untuk mendapatkan bahan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut perbaikan di unit

BAB II
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU
TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1 Kegiatan Pokok

Seperti yang dijelaskan di atas, kegiatan pemantauan indikator mutu Komite Mutu Tahun 2025 yang dilaporkan adalah periode Triwulan III Tahun 2025. Adapun indikator mutu yang dipantau adalah sebagai berikut:

A) Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit
6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit
7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00
8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit
9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
12. Keterlambatan Respon Terhadap Komplain
13. Kepuasan Pasien

B) Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien
 - b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR
 - c. Kepatuhan Pengembalian Obat Sisa Anestesi & Narkotika ke Ruang Farmasi
 - d. Kepatuhan Pelaksanaan *Surgical Safety Checklist* (SSC)
 - e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi
 - f. Kepatuhan Kebersihan Tangan
 - g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Ketepatan pemberian MgSO₄ Pada Pasien PEB
 - b. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS
 - c. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.
 - d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium.
 - e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
 - f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
 - g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA_{1c} $<7\%$
 - h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
 - i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
 - j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis
3. Indikator Berdasarkan Renstra RS
 - a. Kepuasan pasien
4. Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi
 - b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO
 - c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi
5. Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran
 - b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal
6. Praktik Klinis yang Di Evaluasi (17 Diagnosis yang di evaluasi)
 - 1) CVA
 - 2) Batu Ureter
 - 3) Diabetes Millitus

-
- 4) GEA
 - 5) HIV
 - 6) Hipertensi
 - 7) TB
 - 8) Keganasan (Ca Mammae)
 - 9) Pneumonia
 - 10) SC
 - 11) Partus Normal
 - 12) PEB
 - 13) BPH
 - 14) Hydronefrosis
 - 15) PPOK
 - 16) Fraktur terbuka
 - 17) Stroke hemoragik
 - 18) Stroke Trombosis

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan analisis hasil capaian mutu indikator di unit kerja
3. Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian atau mencapai target yang ditentukan
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu di unit kerja
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu di unit kerja secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu (dilakukan setiap bulan)
3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator di unit kerja setiap bulan, serta menyusun program perbaikan mutu dengan teknik PDSA oleh penanggungjawab pengumpul data unit di koordinasikan dengan komite Mutu
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap satu bulan.
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo dengan hasil banchmarking perbandingan capaian mutu dengan RS lain setiap tiga bulan sekali.

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab data mutu unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab. Data hasil pemantauan ditulis pada form laporan harian mutu dan dilakukan validasi kepada kepala unit untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan valid. Jika data sudah valid selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mencari rencana tindak lanjut bagi indikator mutu yang masih belum mencapai target atau standar yang ditetapkan. Hasil pengolahan dan analisis data dituangkan dalam laporan tertulis kemudian akan dilaporkan kepada penanggungjawab mutu rumah sakit setiap bulan dalam rapat koordinasi mutu bulanan.

Penanggung jawab mutu Rumah Sakit selanjutnya akan menentukan langkah untuk membuat rencana tindak lanjut indikator mutu yang belum sesuai targert sebagai bentuk feedback dari pelaporan penanggung jawab mutu di unit.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu

Berikut merupakan hasil pemantauan indikator mutu RS. Prima Husada Sukorejo yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025.

3.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

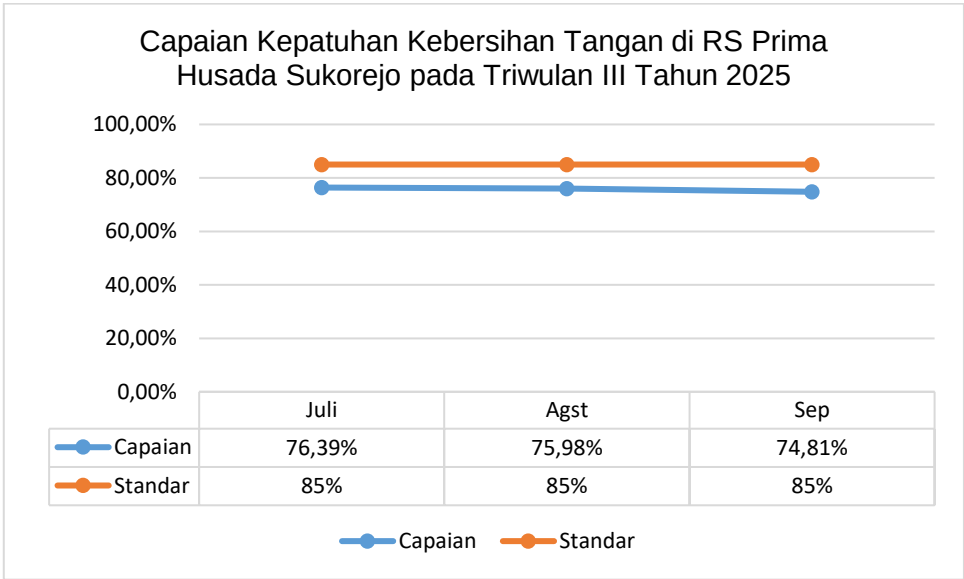
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Bulan Triwulan III Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Juli	Agustus	Septem ber			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	≥85%	75,73%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	92,01%	83,84%	83,55%	100%	86,47%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,80%	99,56%	99,68%	100%	99,68%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	100%	97,30%	100%	≥80%	99,10%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	64,29%	77,96%	61,67%	≥80%	67,97%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	3,68%	3,98%	2,36%	≤5%	3,34%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	80,09%	77,28%	76,10%	≥80%	77,82%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Juli	Agustus	Septe mber			
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,19%	98,99%	100%	≥80%	99,39%	Dipertaha nkan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	98,63%	97,68%	98,55%	100%	98,29%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertaha nkan
13	Kepuasan Pasien	95,00%	88,10%	93,10%	≥76.61%	92,07%	Dipertaha nkan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan III yakni mencapai 75,73%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu ≥85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Triwulan III 2025 hanya mencapai 75,73%, belum mencapai target ≥85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai

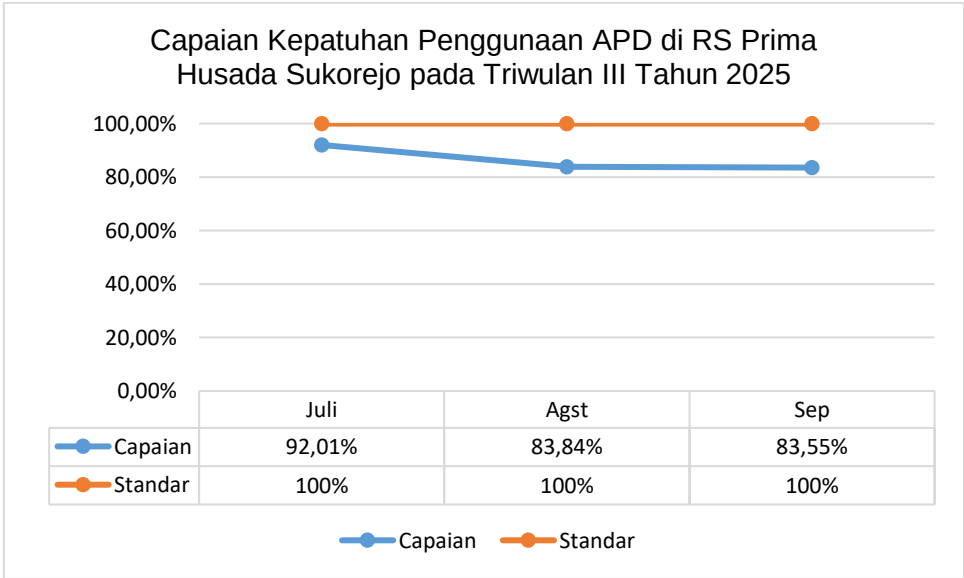
	target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan bulan Triwulan III 2025 sebesar 75,73%. b. Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. c. Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. 2. Tujuan: a. Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli – September 2025). b. Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan 3. Rencana Aksi: a. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). b. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. c. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	1. IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu 2. Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. 3. Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	1. Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan III 2025 yaitu 75,73% 2. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan tertinggi yakni unit Farmasi sebesar 100% 3. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 85,19% walaupun belum mencapai standar 4. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO 5. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan a) Sebelum kontak dengan pasien sebesar 58,43% b) Sebelum Tindakan aseptik sebesar 65,98% c) Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67% d) Setelah kontak dengan pasien sebesar 66,10% e) Setelah dari lingkungan pasien sebesar 67,23%
Action	1. Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). 2. Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. 3. Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentas i hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/m inggu/ unit

2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (September–Desember 2025)

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan III yakni mencapai 86,47%. Terjadi penurunan signifikan 8% dari bulan Agustus ke Bulan Juli Tahun 2025. Tetap hasil capaian di bulan september hampir sama dengan bulan Agustus 2025. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan penggunaan APD masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan III Tahun 2025

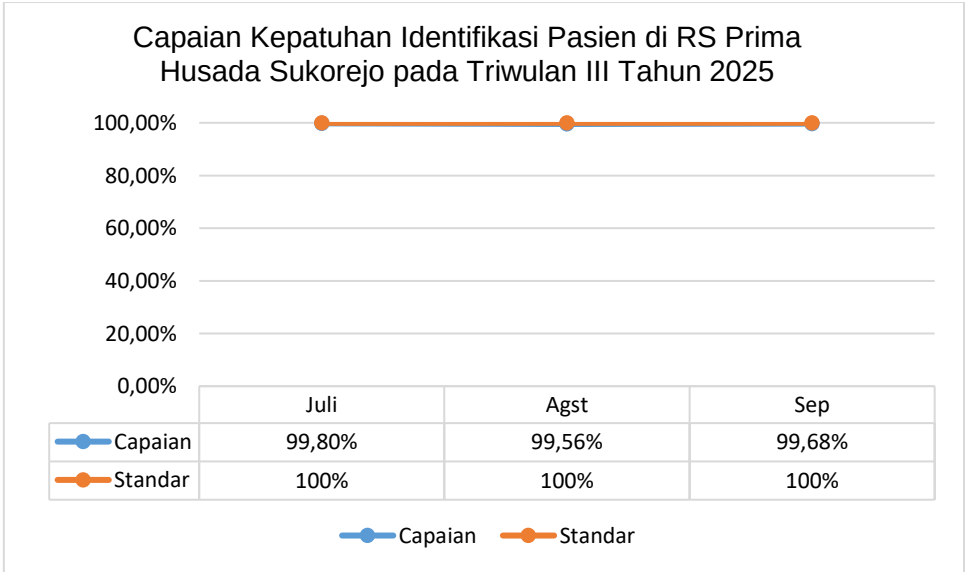
Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 86,47%. Meskipun pelatihan penggunaan APD telah dilaksanakan pada bulan Mei (untuk Pelatihan PPI seluruh staf) dan diperkuat kembali dalam pelatihan PMKP bulan Juni dan Triwulan III, tingkat kepatuhan penggunaan APD masih belum mencapai target 100%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 86,47%. - Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. - Tujuan: - Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. - Rencana Aksi: - Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian.
Do	- Melakukan observasi langsung terhadap penggunaan APD staf CS dan Unit Umum pasca pelatihan - Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur.
Study	- Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 86,47% belum mencapai target 100% - Monitoring menunjukkan unit yang mendapat pelatihan lebih aware, namun perubahan perilaku belum konsisten. - Evaluasi pelatihan menunjukkan perlunya penguatan praktik langsung dan coaching on the spot, bukan hanya teori.
Action	- Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- Observasi langsung - Pembinaan di tempat (real-time coaching) - Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	1 Bulan
2	Audit dan supervisi khusus bagi	Menindaklanjuti hasil pelatihan Juni, Triwulan III	Seluruh unit pelayanan,	Audit mingguan	IPCN, Karu, Superviso	1 Bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	staf yang sudah mendapatkan pelatihan	dan memperkuat penerapan di lapangan	penunjang, Umum	- Supervisi oleh IPC dan Karu - Penguatan budaya kerja aman	r CS, Koordinator Unit Umum	
3	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja - Poster visual dipasang di area kerja - Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	1 Bulan
4	Peningkatan peran Karu dan supervisor dalam monitoring harian	Memastikan keberlanjutan kepatuhan di level unit	Seluruh unit pelayanan, penunjang, Umum	- Format pelaporan ketidaksesuaian harian - Pengingat briefing harian - Koordinasi antar shift	Kepala Ruang	1 Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III 2025 mencapai 99,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan III Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,68%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi.

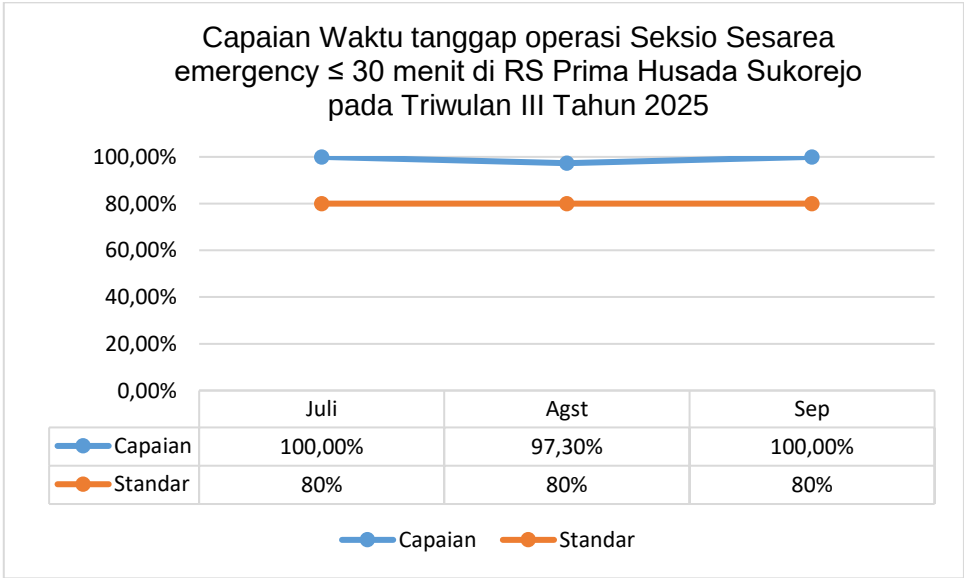
	Akar Masalah yang teridentifikasi: 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Proses identifikasi tidak dilakukan menyeluruh (hanya tanya nama tanpa verifikasi gelang/etiket). 3. Tidak semua unit konsisten dalam pelaksanaan audit internal. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP d. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 99,68%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

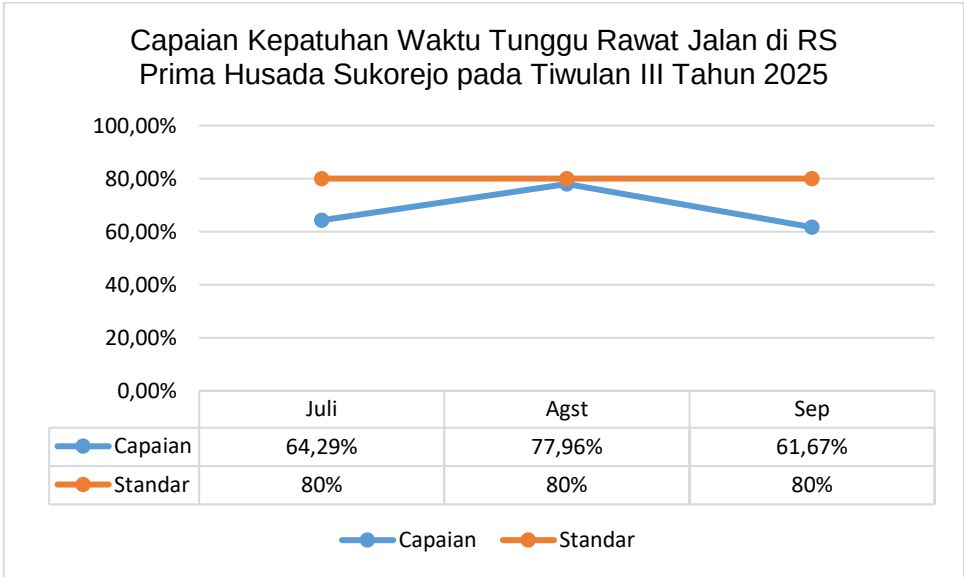


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 99,10%. Dari 103 pasien yang diobservasi, 1 pasien yang mendapatkan pelayanan tanggap SC Emergency lebih dari 60 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 67,97%. Capaian pada bulan September adalah yang **terendah** dari periode tiga bulan ini.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan III Tahun 2025

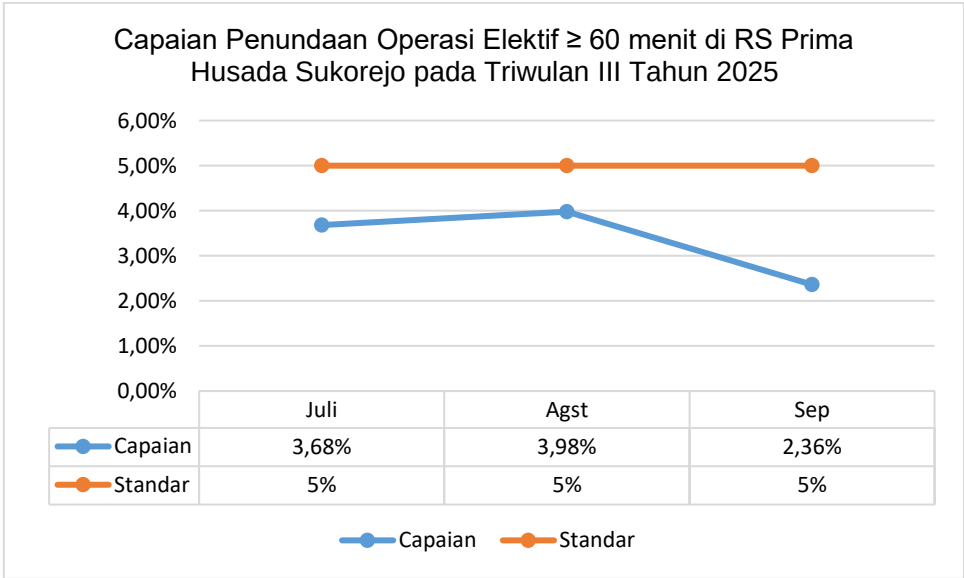
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 67,97% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 7 menit melebihi standar maksimal 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	Masalah yang ditemukan : Rata-rata waktu tunggu rawat jalan masih tinggi, yakni 1 jam 7 menit, dengan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu tunggu ≤ 60 menit hanya sebesar 67,97%. Tujuan : Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi: 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Triwulan III yakni 67,97% belum mencapai ≥ 80%. 2. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 7 menit. Ini dikarenakan: a. Penumpukan Pasien di Awal Jam Poli b. Beberapa dokter spesialis tidak datang tepat waktu sesuai jadwal praktik yang telah ditentukan,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤60 menit yakni 67,97% belum mencapai ≥ 80%. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 7 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penjadwalan ulang atau pembagian tugas pasien di poli untuk DPJP	Meningkatkan pemerataan pasien per DPJP dan mengurangi waktu tunggu	Pasien rawat jalan di poli spesialis	- Review kuota pasien per DPJP - Penjadwalan slot waktu per dokter	Komite Medik, Koordinator Poli	Satu bulan
2	Monitoring kedatangan dokter dan evaluasi disiplin waktu praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan
3	Edukasi pasien datang sesuai jadwal melalui call	Meningkatkan kedisiplinan waktu kedatangan	Pasien rawat jalan	Petugas call center memberi reminder jam kedatangan	Pendaftaran & CSO	Satu bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	center/pendaftaran online	pasien sesuai slot waktu		saat reservasi Edukasi saat konfirmasi jadwal online		

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

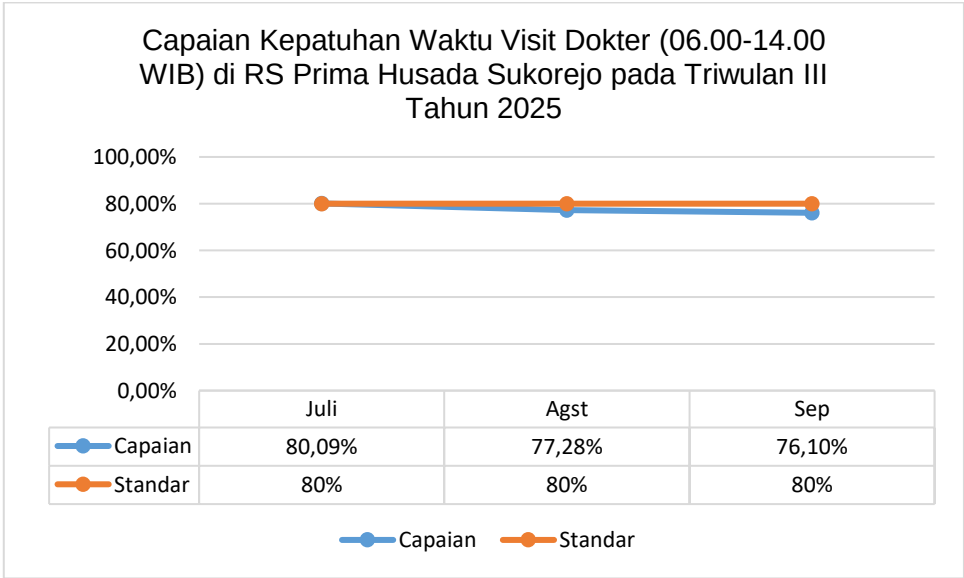


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III tahun 2025 yakni 3,34%. Capaian ini sudah mencapai standar < 5 %.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 77,82% belum memenuhi standar minimal ≥ 80%. Capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu, sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan III Tahun 2025

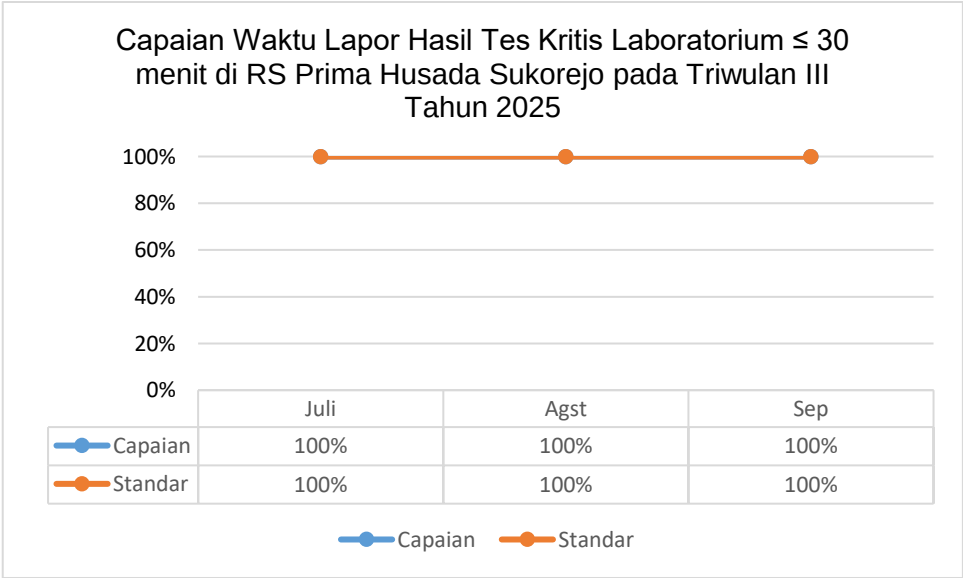
Problem	Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 77,82% belum mencapai standar 80%
Step	Analisa kepatuhan waktu visite dilakukan setiap bulan melalui monitoring dan rekap data visite dokter dari unit rawat inap, dengan membandingkan waktu kunjungan aktual terhadap waktu yang ditentukan
Plan	Identifikasi Masalah : 1. Beberapa dokter spesialis belum melaksanakan visite pasien tepat waktu sesuai jadwal kerja RS. 2. Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. 3. Terdapat dokter yang cuti, tapi digantikan oleh dokter jaga Tujuan : 1. Meningkatkan rata-rata kepatuhan visite minimal 80% Rencana Aksi: 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi ≤ 14.00 WIB) 2. Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. 3. Dokumentasi kunjungan DPJP melalui tanda tangan/paraf di form visite sebagai bukti telah dilakukan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 77,82% yang berarti telah memenuhi standar minimal ≥80%. Namun, sebagian dokter spesialis belum melaksanakan visite secara tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Ketidaktepatan waktu ini berisiko menyebabkan keterlambatan dalam: 1. Pengambilan keputusan medis 2. Pelaksanaan terapi 3. Perencanaan pemulangan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut dan pengawasan rutin untuk meningkatkan mutu pelayanan medik
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 77,82%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang ≥ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter		(DPJP) di rumah sakit			
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokument asikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan
4	Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis	Meningkatka n kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada pasien rawat inap khususnya pasien kritis di ICU melalui sistem koordinasi dan prioritasasi yang lebih baik.	Dokter Penanggung g Jawab Pasien (DPJP) dan pasien kritis yang dirawat di ICU	- Menyusun daftar harian pasien kritis yang membutuhka n prioritas visite. - Melaksanak an koordinasi pagi antara perawat ICU dan DPJP sebelum jam visite	Kepala Ruang ICU, DPJP, Komite Medi	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

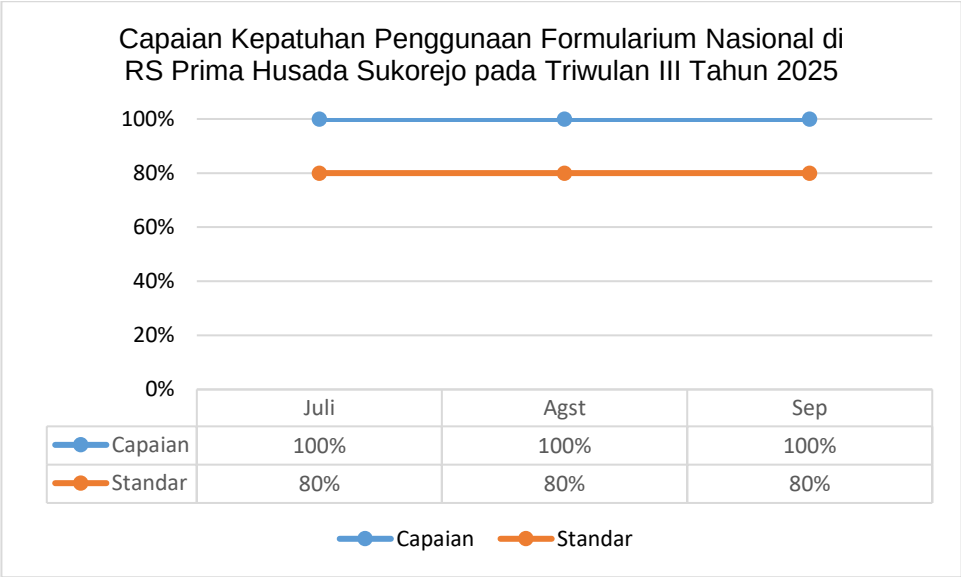


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

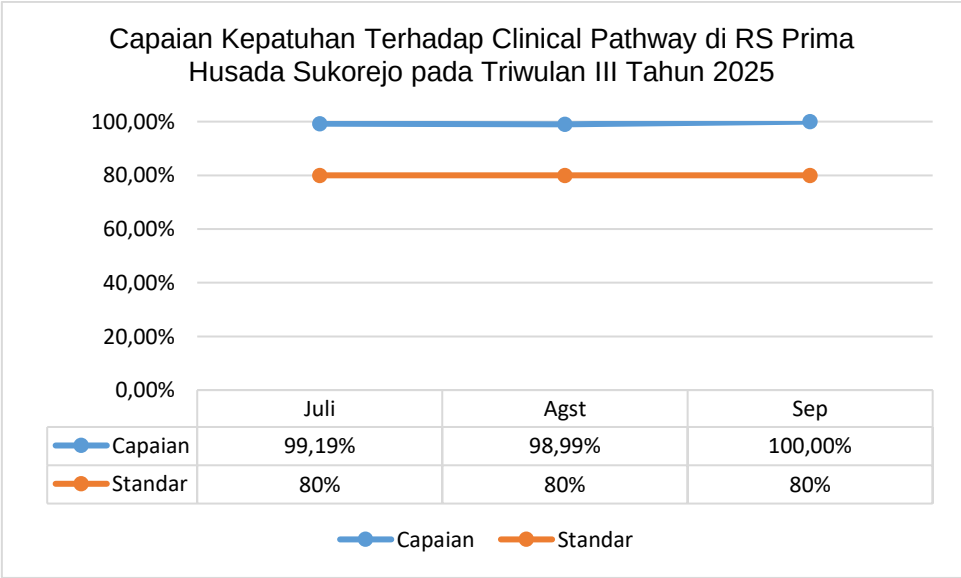


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepsan obat hanya dari Formularium Nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

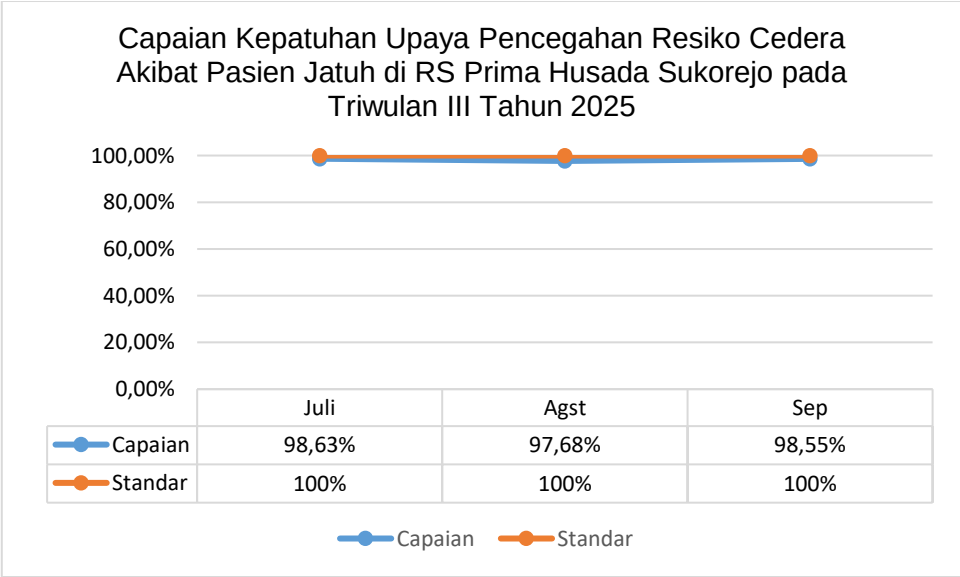


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Triwulan III Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,39%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Triwulan III didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan III tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

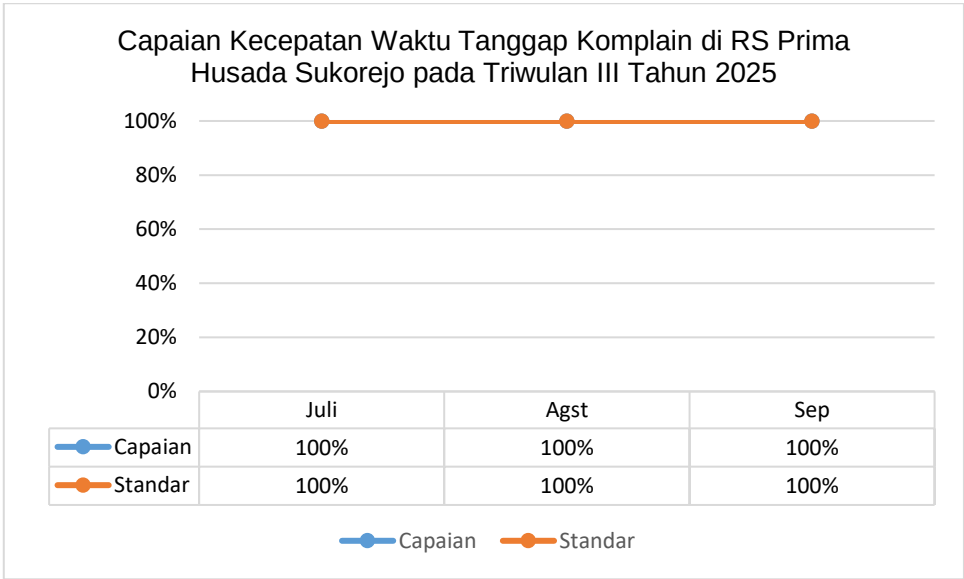
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% - Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni dan Juli 2025, belum seluruh petugas melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : - Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing - Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh - Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten - Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar - Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien - Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap - Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% - Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda).

	3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,29% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	• Ceklist ketersediaan hand rail per shift • Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	• Standarisasi label risiko jatuh • Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	• Laporan hasil audit dibagikan tiap unit • Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

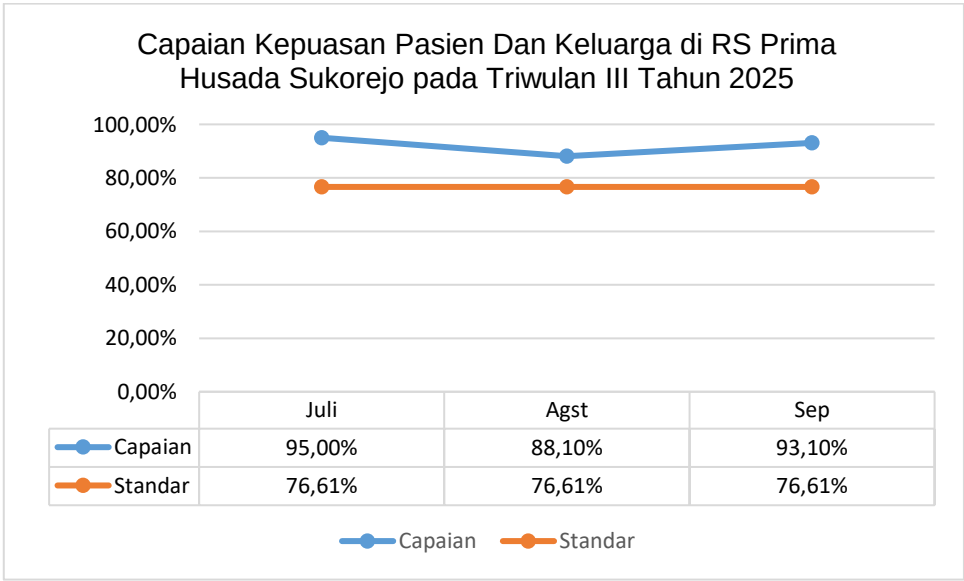


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 92,07%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Triwulan III Tahun 2025

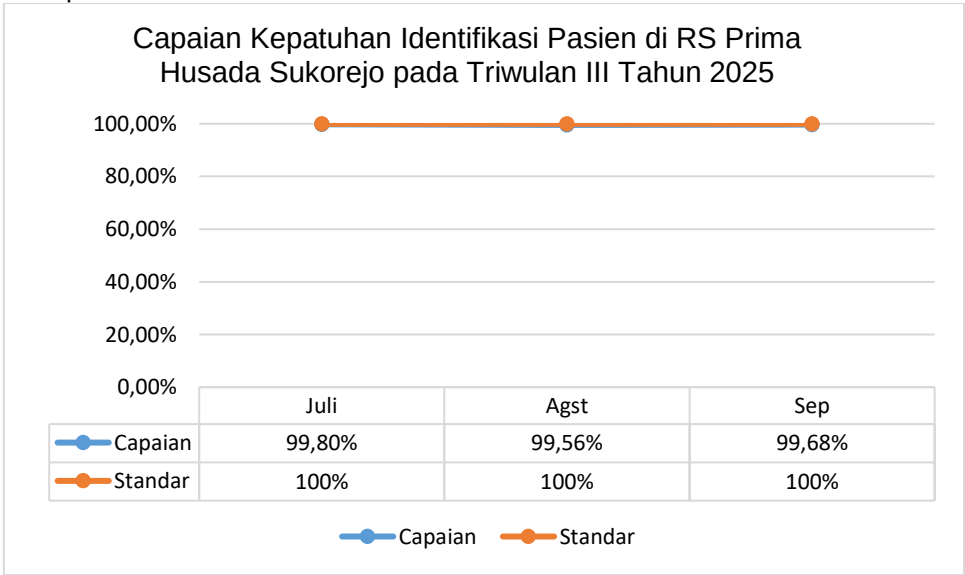
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Juli	Agustus	September			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,80%	99,56%	99,68%	100%	99,68%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,05%	97,82%	98,35%	100%	97,74%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Obat Sisa Anestesi
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		b. Kejadian tidak dilakukannya penandaan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	100%	75,73%	PDSA

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Juli	Agustus	September			
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,63%	97,68%	98,55%	100%	98,29%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		2. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		Belum diisi
		4. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		Belum diisi
		5. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		Dipertahankan
		6. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
		7. Pasien diabetes mellitus yang				≥ 70%		Belum diisi

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Juli	Agustus	September			
		mencapai target HbA1c <7%						
		8. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		Belum diisi
		9. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Belum diisi
		10. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		Belum diisi
3	Renstra RS	1. Kepuasan pasien	95,00%	88,10%	93,10%	≥ 76,61 %	92,07%	Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	1. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- 1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III 2025 mencapai 99,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan III Tahun 2025

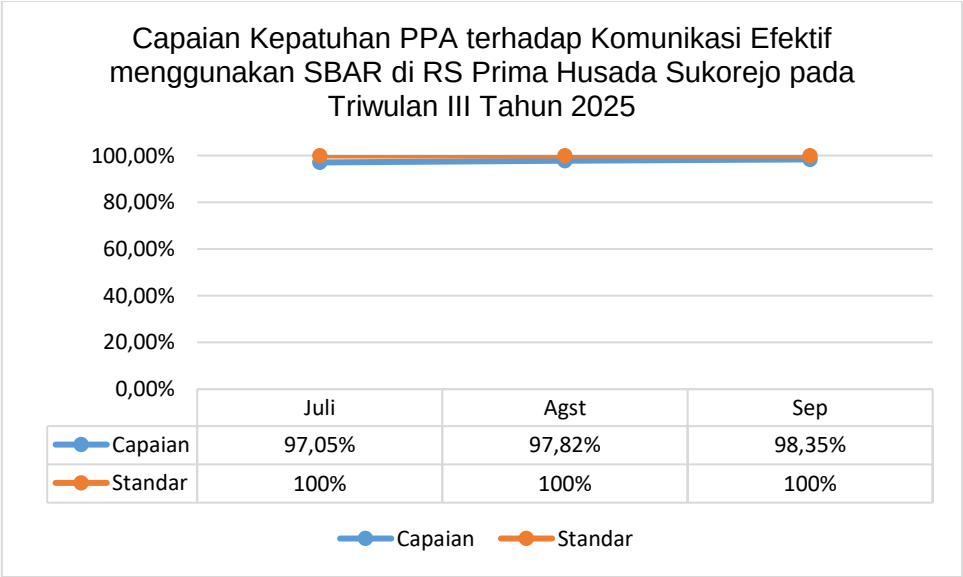
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan III Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,68%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi. Akar Masalah yang teridentifikasi: - Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP - Proses identifikasi tidak dilakukan menyeluruh (hanya tanya nama tanpa verifikasi gelang/etiket). - Tidak semua unit konsisten dalam pelaksanaan audit internal. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : - Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh - Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP - Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	- Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh - Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). - Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Study	Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 6 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IGD, IRNA 2A, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, dan Farmasi.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 99,68%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan III Tahun 2025 yakni 97,74%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan III Tahun 2025

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,74%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Identifikasi Masalah: Tingkat kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) terhadap penggunaan komunikasi efektif dengan format SBAR belum mencapai standar 100%. Hasil monitoring menunjukkan adanya variasi dalam penerapan, terutama pada bagian <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i>, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap penggunaan komunikasi SBAR hingga mencapai 100% pada seluruh unit pelayanan, khususnya pada proses serah terima pasien dan komunikasi antar-profesi 3. Rencana Aksi: a. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. c. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. d. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

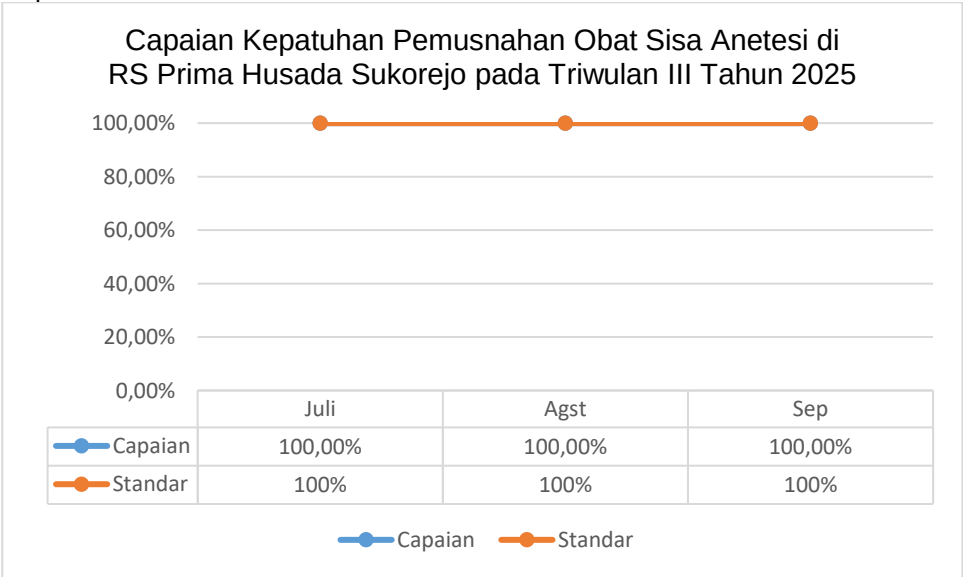
	a. Bagian TTD Pemberi pesan b. Bagian TTD penerima pesan 3. Ini disebabkan karena: a. SBAR disiapkan setelah tindakan dilakukan bukan sebelum komunikasi klinis b. Petugas tidak memahami pentingnya informasi klinis pasien secara menyeluruh c. Kelalaian teknis
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 yakni 97,74%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. 3. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. 4. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi Pelaksanaan Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya.	Supervisi, pemberian umpan balik langsung dan edukasi singkat kepada petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	PKRS, Tim SKP, dan Tim Mutu	1 minggu
2	Monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya	Monitoring dan evaluasi petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	Kepala Ruangan	1 bulan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
		kualitas pelayanan.				
3	Penyediaan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi SBAR melalui akses mudah terhadap contoh-contoh praktik baik (best practice) yang tersedia secara digital.	Seluruh PPA (perawat, bidan, tenaga medis) di seluruh unit pelayanan, khususnya yang melakukan serah terima pasien, komunikasi antar shift, dan komunikasi antar profesi.	Menyusun beberapa contoh SBAR yang baik dan lengkap yakni dalam bentuk dokumentasi tertulis	Tim SKP, PKRS	1 bulan
4	Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap	Memberikan pembinaan dan perbaikan langsung kepada tenaga kesehatan yang tidak mengisi form SBAR secara lengkap	Seluruh tenaga kesehatan (perawat, bidan, atau tenaga lainnya) yang form SBAR tidak lengkap dan pengisian SBAR tetapi tidak terdokumentasi dengan benar	4. Menunjukkan bagian yang tidak terisi dan jelaskan dampaknya terhadap keselamatan pasien. 5. Berikan contoh pengisian yang benar dan arahkan untuk perbaikan ke depan	Tim SKP, PKRS	1 bulan

c. Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi

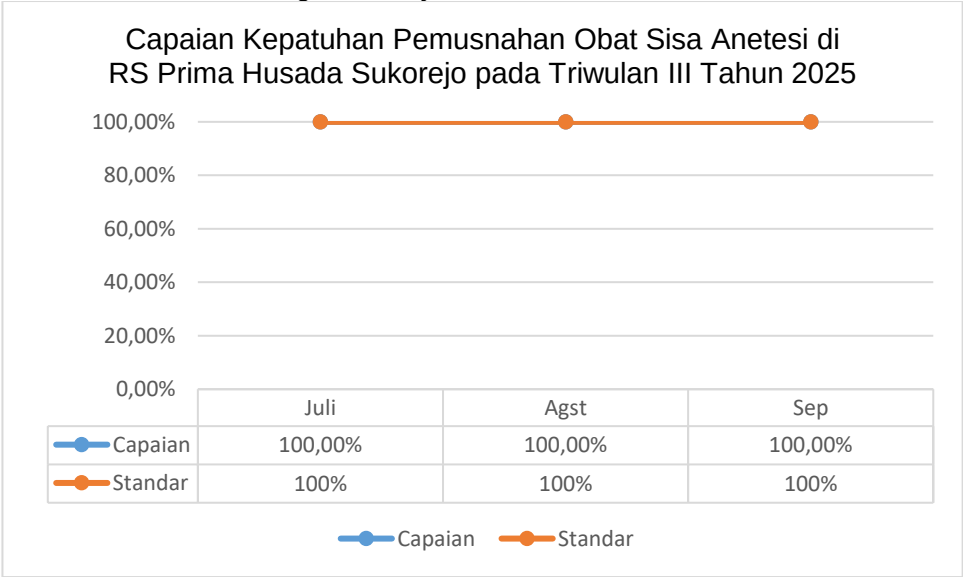


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemusnahan obat sisa anestesi di rumah sakit sudah berjalan sesuai prosedur, dan kontrol terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan anestesi sudah diterapkan secara maksimal.

d. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist

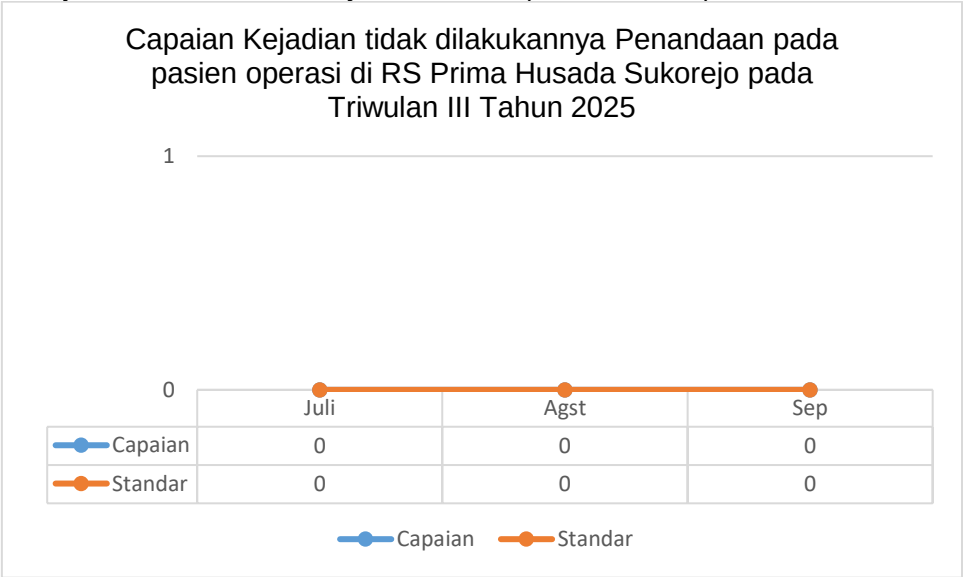


Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Sfety Checklist di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Kepatuhan pelaksanaan Surgical Safety Checklist (SSC) mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keselamatan pasien pra, saat, dan pasca operasi telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai standar WHO.

e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi

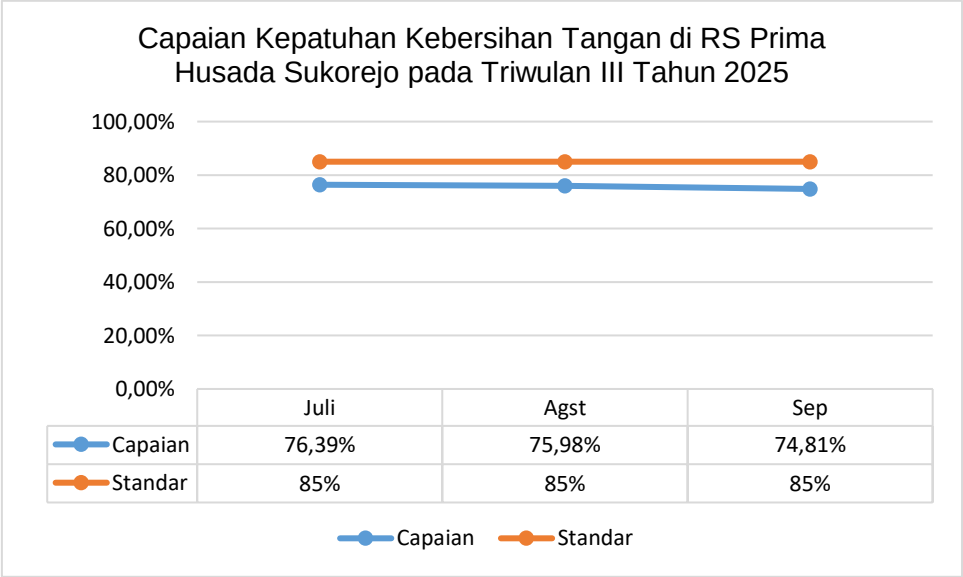


Gambar 3.19. Capaian Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai target 0 kejadian. Angka kejadian tercatat nol (0) dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan III yakni mencapai 75,73%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu $\geq 85\%$. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan III

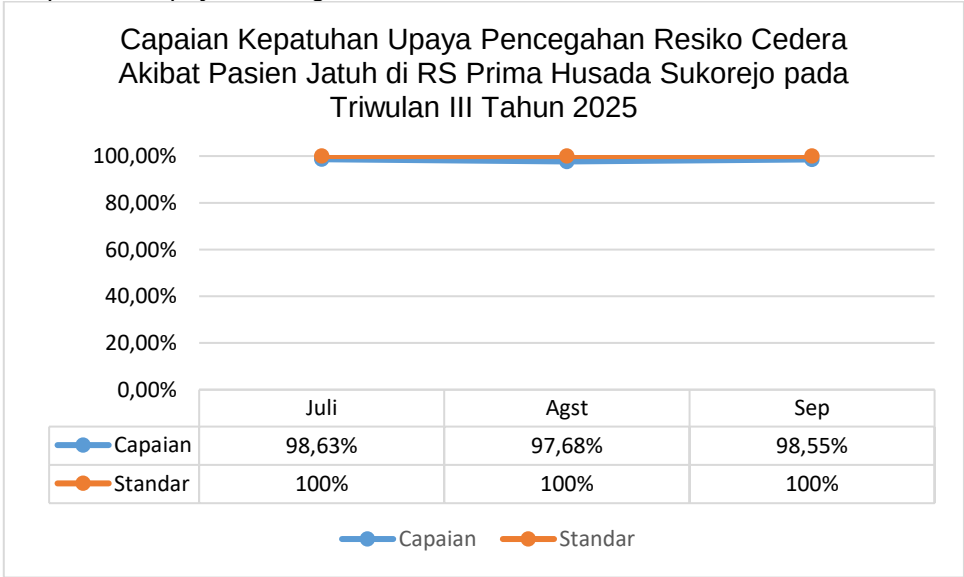
Tahun 2025	
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Bulan Triwulan III 2025 hanya mencapai 75,73%, belum mencapai target $\geq 85\%$.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan bulan Triwulan III 2025 sebesar 75,73%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. - Tujuan: - Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli – September 2025). - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan - Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	- IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu - Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. - Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan III 2025 yaitu 75,73% - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan tertinggi yakni unit Farmasi sebesar 100% - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 85,19% walaupun belum mencapai standar - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan - Sebelum kontak dengan pasien sebesar 58,43% - Sebelum Tindakan aseptik sebesar 65,98% - Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67% - Setelah kontak dengan pasien sebesar 66,10% - Setelah dari lingkungan pasien sebesar 67,23%
Action	- Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit observasional terfokus per	Mengetahui secara langsung	Seluruh tenaga kesehatan di	- Observasi langsung oleh	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
	unit dengan pendekatan bedside coaching	tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	masing-masing unit	IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi		unit (Triwulan III–Sept 2025)
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Triwulan III–Des 2025)

g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.21. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan III tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,29%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni dan Juli 2025, belum seluruh petugas melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar 5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,29% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak tertempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,29% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing 2. Memastikan hand rail terpasang di seluruh tempat tidur pasien, terutama pasien dengan risiko jatuh 3. Menyediakan dan memastikan stiker risiko jatuh dan penanda visual (tanda di kursi roda, tempat tidur, dll) tersedia dan digunakan secara konsisten 4. Melakukan audit rutin (misalnya mingguan atau bulanan) untuk memastikan setiap langkah pencegahan sudah dilakukan sesuai standar

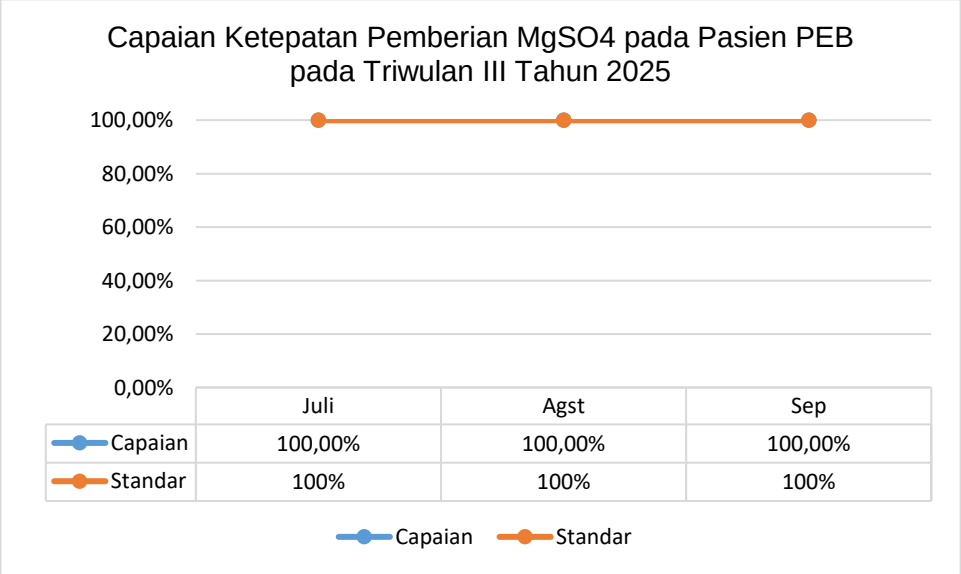
	5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit atau individu yang belum memenuhi standar.
--	---

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pembacaan SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh petugas terkait penanganan pasien risiko jatuh pada morning briefing	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP penanganan pasien risiko jatuh	Seluruh petugas di unit pelayanan yang menangani pasien risiko jatuh	Penguatan edukasi melalui briefing harian	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan
2	Memastikan hand rail terpasang di tempat tidur pasien risiko jatuh	Menjamin keamanan fisik pasien	Pasien risiko tinggi jatuh	- Ceklist ketersediaan hand rail per shift - Koordinasi dengan bagian pemeliharaan	Ka. Ruangan IPSRS	Satu Bulan
3	Pengadaan dan penggunaan stiker serta penanda visual risiko jatuh	Meningkatkan kesadaran visual terhadap pasien berisiko	Petugas dan keluarga pasien	- Standarisasi label risiko jatuh - Distribusi ulang penanda ke tiap unit	Gudang Tim mutu	Satu Bulan
4	Audit rutin kepatuhan tindakan pencegahan risiko jatuh	Monitoring implementasi di lapangan	Setiap unit rawat inap	Observasi lapangan	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan
5	Pemberian umpan balik langsung	Meningkatkan perbaikan berkelanjutan	Petugas yang belum patuh	- Laporan hasil audit dibagikan tiap unit - Tindak lanjut individu	Kepala Ruangan Tim Mutu	Satu Bulan

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

a. Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB



Gambar 3.22. Capaian Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

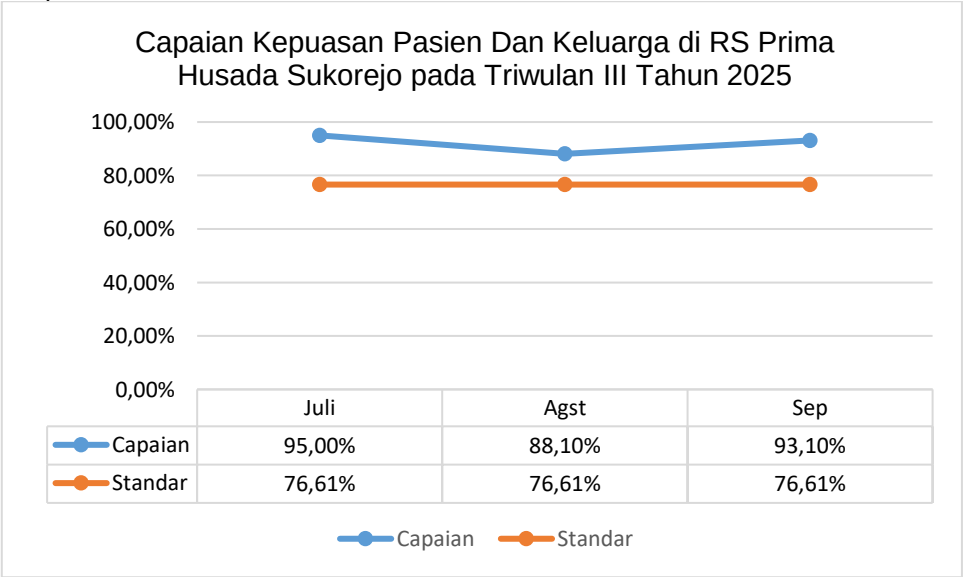
Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025 yakni mencapai 100%.

- b. Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS
- c. Pasien dengan Dengue yang Mendapatkan Pemantauan dan Intervensi Tepat Waktu untuk Mencegah Komplikasi Berat (Seperti Shock atau Perdarahan) dalam 24 Jam Pertama Setelah Diagnosis
- d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium
- e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
- f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
- g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%
- h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
- i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
- j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis

3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS

a. Kepuasan Pasien

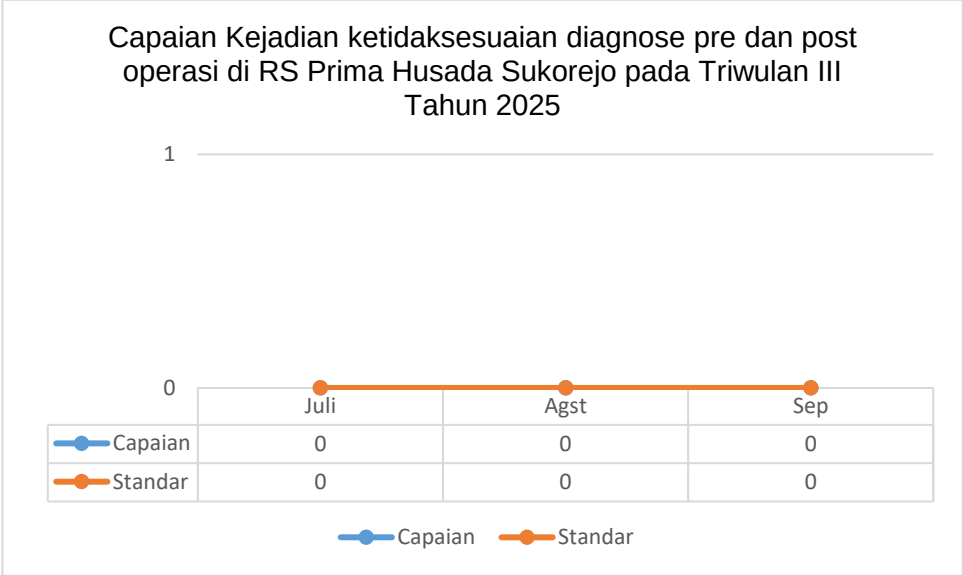


Gambar 3.23. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 92,07%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem
- a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi

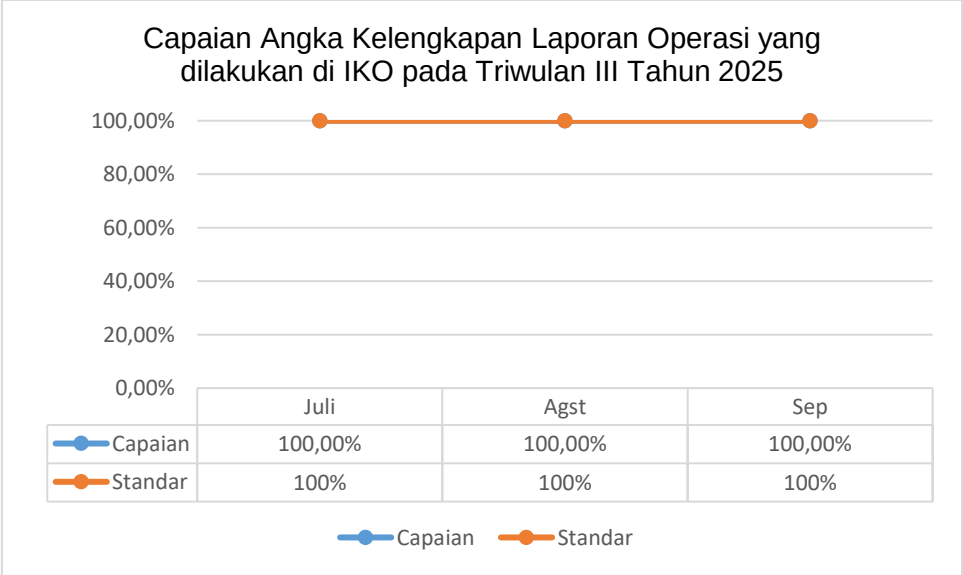


Gambar 3.33. Capaian Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan III Tahun 2025 capaian kejadian ketidaksesuaian diagnose pre & post operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Angka tersebut sudah mencapai target 0 kejadian.

- b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO

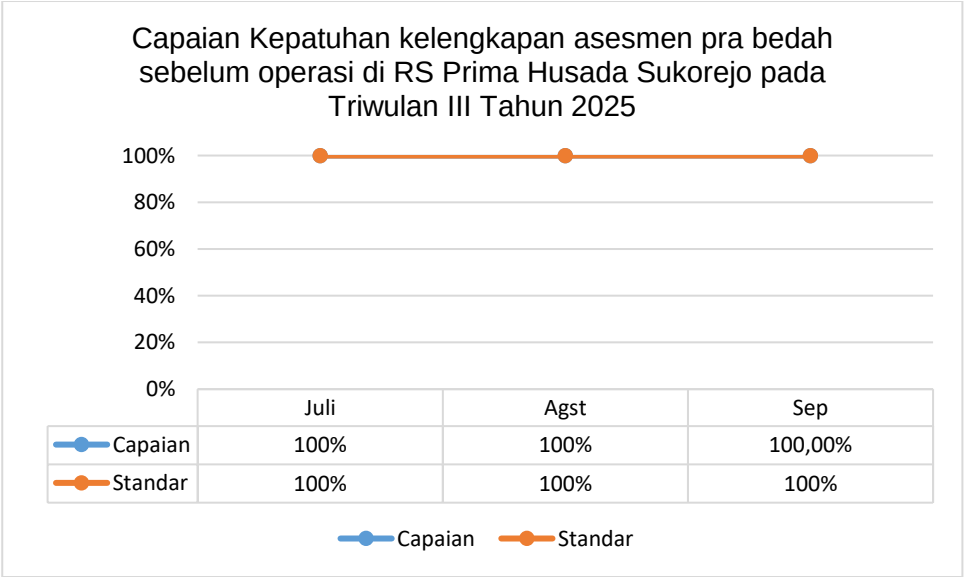


Gambar 3.34. Capaian Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang dilakukan di IKO di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100% sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

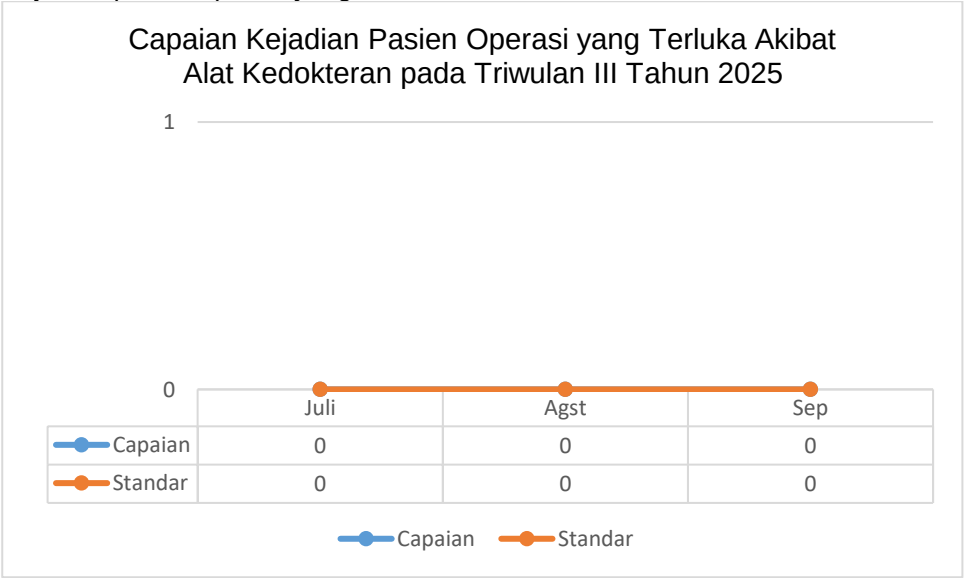


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prosedur asesmen pra bedah sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin yang terstandarisasi di ruang tindakan/pre-operatif.

- 5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran



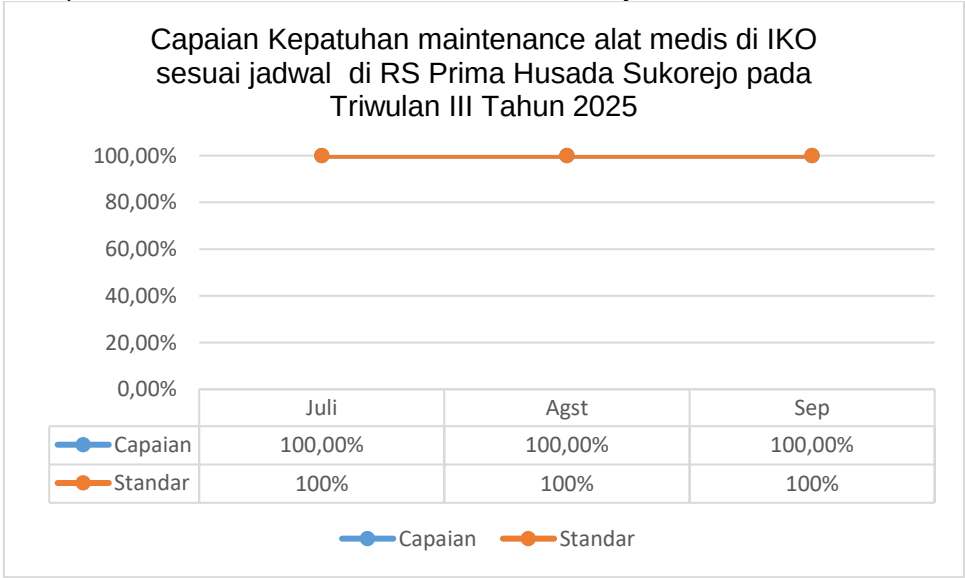
Gambar 3.36. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Pada bulan Maret 2025, telah dilakukan pergantian alat kedokteran,

khususnya harum pen. Dampak positifnya pada Triwulan III Tahun 2025 yakni menurunnya risiko cedera pada pasien operasi, dan meningkatkan kinerja tim bedah dan sterilisasi karena alat sudah memenuhi standar.

b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal



Gambar 3.37. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan III Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.16 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan III Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	93,55%	95,48%	100%	96,34%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,80%	71,43%	75%	≥ 85 %	78,08%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	100%	97,62%	94,74%	≥ 76,61 %	97,45%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	88%	100%	96,00%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif	98,06%	95,48%	88,39%	100%	93.98%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	menggunakan SBAR						
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%		Tidak ada obat sisa anestesi yang dimusnahkan
3	Pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	95,48%	96,77%	100%	97,42%	PDSA
2	Kematian pasien < 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	11/1000	7/1000	13/1000	≤ dua per seribu	11/1000	PDSA
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	89,03%	87,10%	88,39%	100%	88,17%	PDSA
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	98,06%	96,13%	97,86%	100%	93,55%	PDSA
5	Kelengkapan pengisian LOP	88,39%	96,77%	85,81%	100%	90,32%	PDSA
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	100%	74,19%	90,32%	100%	88,17%	Dipertahankan
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit	93,55%	66,45%	90,32%	100%	83,44%	PDSA
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	100%	100%	90,32%	100%	96,78%	Dipertahankan

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.22 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	100%	100,00%	100%	100,00%	PDSA

2	Kepatuhan kebersihan tangan	71,83%	0%	0%	≥ 85 %	23,94%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	76,92%	73,33%	100%	75,13%	PDSA
4	Kepuasan pasien	-	-	-	≥ 76,61%		PDSA
5	Waktu tunggu rawat jalan	64,29%	58,46%	60,81%	≥ 80%	61,19%	PDSA
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	0%	0%	100%	33,33%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		Belum diisi
2	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
3	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		Belum diisi
4	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		Dipertahankan
5	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Belum diisi
6	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	-	41,72%	31,25%	0%	36,49%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	-	100%	100,00%	100%	100,00%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian	-	76,92%	100,00%	100%	88,46%	PDSA

	pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan						
4.	Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien	-	-	100,00%	100%	100,00%	Belum diisi

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	95,38%	96,00%	79,17%	100%	90,18%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	52,50%	69,68%	73,11%	≥ 85 %	65,10%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,92%	96,00%	96,67%	100%	96,53%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	-	91,67%	≥ 76,61 %	95,84%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	79,23%	80,80%	81,67%	≥ 80%	80,57%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,14%	73,33%	91,67%	100%	87,38%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	96,30%	94,94%	96,43%	100%	95,89%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	-		100%	100%	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu $\leq$ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				$\geq 95\%$		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				$\leq 5\%$		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				$\geq 95\%$		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $< 7\%$	25%	17,65%	18,18%	$\geq 70\%$	20,28%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				$\geq 95\%$		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $< 140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				$\geq 75\%$		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,60%	2,65%	1,54%	$\leq 0,24\%$	1,93%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	7 kejadian	4 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	3 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan	96,15%	96,00%	95,83%	100%	95,99%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam						
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	96%	96,80%	96,67%	100%	96,49	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	100%	100,00%	100%	99,57%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	58,93%	69,60%	71,21%	≥ 85 %	66,58%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,13%	96,13%	93,55%	100%	95,27%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	80%	100%	≥ 76,61 %	93,33%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	76,77%	64,52%	68,39%	≥ 80%	69,89%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	81%	71,11%	72%	100%	74,70%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	93,55%	100%	96,77%	100%	96,77%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi		-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau			0,65%	≥ 90%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.						
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu $\leq$ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				$\geq 95\%$		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				$\leq 5\%$		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				$\geq 95\%$		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $<7\%$	0%	0%	9,09%	$\geq 70\%$	3,03%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				$\geq 95\%$		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				$\geq 75\%$		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,73%	0,27%	0,82%	$\leq 0,24\%$	0,61%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan	87,10%	100%	96,77%	100%	94,62%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam						
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	90,32%	88,39%	92,67%	100%	90,46%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	98,71%	98,67%	100%	98,70%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	76,47%	69,23%	75,93%	≥ 85 %	73,88%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	97,42%	98,06%	98,00%	100%	97,83%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	88,89%	88,89%	≥ 76,61 %	92,59%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	85,81%	83,87%	82,00%	≥ 80%	83,89%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-		≥ 80%		Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	69,23%	77,27%	96,30%	100%	80,93%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,42%	98,06%	98,67%	100%	98,05%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis				≥ 95%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	atau konfirmasi laboratorium						
5	Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		
7	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
8	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
9	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,32%	0%	0,65%	≤ 0.24 %	0,32%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	98,06%	98,06%	98,00%	100%	98,04%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

6.
INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.66
Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,35%	96,13%	96,00%	100%	97,60%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	74,29%	69,52%	97,16%	≥ 85 %	71,62%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,77%	92,90%	94,19%	100%	95,00%	PDSA

4	Kepuasan pasien	85,71%	90,48%	83,33%	$\geq 76,61\%$	87,90%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤ 14.00 WIB	61,29%	58,06%	58,06%	$\geq 80\%$	57,56%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)				$\geq 80\%$		Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	76,79%	89,74%	61,90%	100%	88,84%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	93,55%	94,19%	92,90%	100%	93,69%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				$\geq 90\%$		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				$\geq 95\%$		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				$\leq 5\%$		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				$\geq 95\%$		
7	Pasien diabetes mellitus yang	12,50%	1,94%	0,65%	$\geq 70\%$	5,03%	PDSA

	mencapai target HbA1c <7%						
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,63%	0,36%	0%	≤ 0.24 %	0,33%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	1 kejadian	5 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	82,58%	87,10%	94,84%	100%	88,17%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	97,42%	98,06%	96,67%	100%	97,38%	PDSA

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,85%	100%	99,80%	100%	99,88%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	92,00%	71,43%	≥ 85 %	81,72%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	3,68%	3,98%	2,36%	≤ 5%	3,34%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
5	Kepuasan pasien	100%	-		≥ 76,61 %		Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB				100%		Tidak ada pemberian MgSO4 di Ruang IKO
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)				100%		Belum diisi
2.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari				100%		Belum diisi
3.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
4.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.81 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada sisa obat anestesi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0%	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.82 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	97,95%	96,09%	96,13%	100%	96,72%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	85,19%	73,91%	80,00%	≥ 85 %	79,70%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	92,31%	100%	> 80%	97,44%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	93,50%	95,15%	93,50%	≥ 80%	94,05%	Dipertahankan
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	99,19%	98,99%	100%	≥ 80%	99,39%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
13	Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.86 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juni	Juli	Agustus			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	100%	100%	> 80%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61 %	-	Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas RS							

1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	98,28%	100%	99,43%	dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien HPP di Ponok
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponok yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.87 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,10%	91,30%	84,31%	≥ 85%	87,57%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	92,08%	97,65%	84,54%	≥ 80%	91,42%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%		Tidak ada pasien dengan Diagnosa tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							

1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	8 kejadian	7 kejadian	12 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

11. ICU
A. ICU

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	96,55%	100%	98,85%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	81,82%	90,91%	83,33%	≥ 85%	85,35%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	76,00%	75,00%	37,93%	≥ 80%	62,98%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	0%	100%	100%	66,67%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
3	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	Tidak ada pasien ca mammae
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1,96%	0%	0%	≤ 3 %	0,65%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI
Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	-	-	100%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	-	≥ 85%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	-	-	100%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	-	-	-	≥ 80%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	-	100%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan penanganan bronchopneumoni a sesuai dengan kriteria klaim BPJS	-	-	-	100%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	-	-	-	≥ 80%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	-	-	-	≥ 95%		Tidak Ada Pasien ICU Isolasi

12. RADIOLOGI
Tabel 3.94 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	75%	≥ 85%	75%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	99,35%	-	96,77%	100%	98,96%	PDSA
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri		0%	-	100%	-	PDSA
5	Kepuasan pasien				≥ 76,61%		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	95,48%	54,19%	96,77%	100%	82,15%	PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0%	45,81%	12,00%	0%	19,27%	PDSA
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	0,65%	52,90%	45,33%	0%	32,96%	PDSA
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	155 kejadian	20 kejadian	0 kejadian	58 kejadian	PDSA

13. LABORATORIUM

Tabel 3.95 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	74,19%	70%	≥ 85%	72,10%	PDSA
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	80%	100%	80%	PDSA
4	Kepuasan pasien				≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	0,03%	0,03%	0%	0,02%	Dipertahankan
4	Angka ketidaklengkapan	4,43%	15,55%	34,86%	0%	18,28%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	form permintaan laboratorium						
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	0%	0%	< 0,01%	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.99 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	0%	0%	≥ 85%	0%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-			≥ 76,61%		Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	-	-	100%	-	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.100 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	90,32%	100%	100%	96,78%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	100%	76,13%	≥ 85%	88,07%	PDSA
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	-	-	-	≥ 76,61 %		Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%		Tidak ada obat yang dimusnahkan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	73,33%	85,38%	92,00%	100%	83,57%	PDSA
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	79,29%	70%	74,40%	100%	74,56%	PDSA
3	Kejadian kesalahan pernberian obat	0 kejadian	6 kejadian	4 Kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	1 Kejadian	0 Kejadian	3 Kejadian	0 Kejadian	2 kejadian	PDSA
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan	1 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 Kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik						

16. GIZI

Tabel 3.101 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	79,49%	74,36%	≥ 85%	84,62%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	66,67%	81%	100%	82,56%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	95%	88,10%	93,10%	≥ 76,61%	92,07%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	18%	18%	18%	≤ 20 %	18%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	100%	0%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.102 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	95%	88,10%	93,10%	76,61%	92,07%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	94,85%	96,18%	91,27%	100 %	94,10%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Consent	55,17%	67,21%	55,56%	100 %	59,31%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	setelah mendapatkan informasi yang jelas						
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	4 kejadian	4 kejadian	6 kejadian	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	74%	86%	95%	100%	85%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	27%	30,11%	36,67%	0%	31,26%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,15%	96,96%	96,76%	100%	96,96%	PDSA
8	Kelengkapan General Concent	97,73%	96,49%	91,11%	100%	95,11%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	21,29%	9,09%	66,15%	100%	32,18%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.103 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD = 9,53 mg/l b. COD = 38,92 mg/l c. TSS = 5,72 mg/l d. PH =7,20	a.BOD = 9,28 mg/l b. COD =38,35 mg/l c. TSS = 5,6 mg/l d. PH 7,4	a. BOD = 15,22 mg/l b. COD = 50,59 mg/l c. TSS < 5,80 mg/l d. PH 7,10	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a.BOD = 11,33 mg/l b. COD = 42,62 mg/l c. TSS = 5,7 mg/l d. PH 7,2	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	-	100%	100 %	100%	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	66,15%	66,15%	66,15%	100%	66,15%	1 Tahun
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

19. SDM

Tabel 3.104 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	22,22%	54,07%	58,96%	100 %	45,08%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	≥ 60 %	0%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	0,88%	1,32%	1,09%	≤10% / bulan	1,10%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	9,43%	8,55%	10,89%	0%	9,62%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	65,02%	65,92%	65,92%	100%	65,92%	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	69%	69%	69%	≥ 80 %	69%	semesteran
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.105 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %	100%	100%	100 %	100%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	100%	96,67%	100%	96,67%	Dipertahankan
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	80%	98,18%	100%	100%	100%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.106 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan	Standar	Rata-rata	Keterangan
-----	-----------	-------	---------	-----------	------------

		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.107 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.108 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
ATEM							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	75%	0,00%	≤ 80%	58,33%	PDSA
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	-	100%	100%	100%	100%	Tidak ada alat medis kritikal
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	-	-	5,12%	100%	5,12%	Alat di Kalibrasi di Bulan September
IPSRS							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis ≤ 15 menit	48,63%	15,96%	6,94%	100%	23,84%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	50%	0,00%	100%	50,00%	PDSA
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)			0,00%	100%	0,00%	Belum diisi

24. LAUNDRY

Tabel 3.109 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan	Standar	Keterangan
-----	-----------	-------	---------	------------

		Juli	Agustus	September		Rata-rata	
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan penggunaan APD	70%	0%	0%	100%	23,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kejadian linen yang hilang	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	2 kejadian	2 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	PDSA
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.110 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar 135 derajat (merubah pedoman di 2025)	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	96,39%	95,93%	96,97%	100%	96,43%	PDSA (IGD, Poli, IRNA 2A)
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	96,99%	97,41%	98,48%	100%	97,63%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman	96,99%	96,76%	96,97%	100%	96,91%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)						
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	PDSA

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.111 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	0%	98,35%	99,44%	100%	65,93%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	99,34%	100%	100%	99,78%	PDSA
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	99,66%	100%	100%	99,89%	PDSA
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100%	97,33%	92,86%	100%	96,73%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	100%	94,89%	100%	98,30%	Dipertahankan

27. KEAMANAN

Tabel 3.112 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	1 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	99,25%	98,56%	100%	99,27%	PDSA
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	1071 kejadian	485 kejadian	321 kejadian	0 kejadian	625 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	98,60%	95,05%	95,22%	100%	96,29%	PDSA
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	85,48%	84,19%	87,11%	100%	85,59%	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.113 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	95,41%	94,81%	89,47%	100%	93,23%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT ≤ (lihat SPO)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.114 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	76,39%	75,98%	74,81%	≥ 85%	75,73%	PDSA
2.	Kepatuhan APD	92,01%	83,84%	83,55%	≥ 100%	86,47%	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI							
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	90%	90%	82,80%	60 %	87,60%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75,19%	76,00%	76,00%	75 %	75,73%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
3.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0,55%	0%	≤ 1,5%	0.18%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	90%	100%	86,96%	100%	92,32%	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	90%	88,85%	90%	100%	89,62%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	94,11%	94,11%	90,71%	100%	92,98%	PDSA
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	66,67%	69,58%	78,63%	100%	71,63%	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	47,06%	47,06%	88,89%	100%	61,00%	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.115 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	52,68%	61,61%	51,79%	100%	55,36%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	85,71%	51,79%	100%	79,17	PDSA
3.	Ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi	73,17%	30,36%	30,36%	100%	44,63%	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	52,68%	61,61%	58,04%	100%	57,44%	PDSA
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, SBAR)	97,05%	100%	100%	100%	99,02%	PDSA
6.	Kepatuhan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
	komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)						

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.116 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS	93,00%	93,81%		80%		Belum diisi
2.	kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	99,60%	99,74%		100%		Belum diisi
3.	Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyeteroran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam	95,54%	95,18%		100%		PDSA
4.	kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	93,91%	94,74%		100%		Belum diisi
5.	Kejadian berkas pending klaim pasien BPJS	161 kejadian	1413 kejadian		0 kejadian		Belum diisi

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepuasan Pasien MCU	100%	0%	100%	≥ 76,61%	66,67%	PDSA
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0,03%	0,03%	0,06%	10% / tahun	0,04%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Responstime CSO <30 mnt (WA)	12,21%	10,93%	10,49%	100%	11,21%	PDSA
2.	Ketepatan perubahan	-			100%		Adanya SE tentang

	jadwal dokter spesialis						Penyesuaian Kebijakan Sesuai HFIS Versi 6.0
--	-------------------------	--	--	--	--	--	---

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	95%	88,10%	93,10%	≥ 76,61%	92,07%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP							
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

35. TB di IRJA

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	100%	100%	100%	≥ 90%	100%	Dipertahankan

36. KEUANGAN

Tabel 3.122 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0%	0%	0%	<5%	0%	Dipertahankan
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
4	Jumlah piutang $\geq$ 60 hari				0%		Belum ada capaian

37. TIM HIV

Tabel 3.123 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	100%	0%		$\geq$ 90%		Belum diisi

38. KB

Tabel 3.124 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	13,16%	18,18%	17,56%	50%	16,30%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	86,86%	96,80%	89,73%	30%	91,13%	Dipertahankan

39. STUNTING

Tabel 3.125 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Bulan Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	0%	0%	100%	100%	33,33%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali				100%	-	Triwulanan PDSA
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

40. IT - SIM RS

Tabel 3.126 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan III Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Juli	Agustus	September			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	94,44%	100%	98,14%	PDSA
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	85,71%	100%	95,23%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	54,76%	47,62%	53,85%	100%	52,07%	PDSA